

皮膚科國考複習

改編 from TINY notes 馬聖翔學長

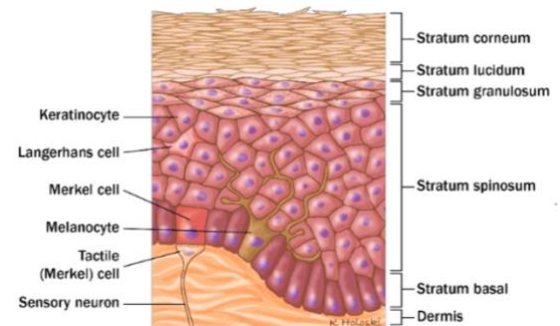
Table of Contents

一、 皮膚組織學：	1
二、 濕疹(Eczema)與皮膚炎	1
三、 乾癬與糠疹	3
四、 水疱病	4
五、 色素性皮膚疾患	5
六、 感染性皮膚疾病	6
七、 皮膚附屬器疾患	9
八、 良性皮膚疾患	10
九、 癌前病灶與皮膚癌症	11
十、 藥物疹	12
十一、 自體免疫疾病	13
十二、 遺傳性疾病	13
皮膚科的 Sign	14

一、皮膚組織學：

上皮(epidermis)、真皮(dermis)、皮下組織

- (1) 上皮層：角質層（死掉的角質細胞）、透明層（厚的角質細胞層，只在手/腳掌）、顆粒層（失去細胞核的角質細胞）、棘狀層（多角型，以 desmosome 相連）、基底層（上皮細胞新生處、Merkel cell、黑色素）
- (2) 真皮層：含有許多纖維、皮膚附屬器官（如毛囊、皮脂腺）



二、濕疹(Eczema)與皮膚炎

異位性皮膚炎 Atopic dermatitis

- 兒童常見，多具有異位性體質=同時合併過敏性鼻炎、氣喘，具家族傾向，血中 IgE ↑
- 免疫機轉：
 - 急性期：TH2、IL-4、IL-13
 - 慢性期：TH1、IL-5、IL-12、IGM-CSF、INF-γ
- 和皮膚的功能缺損有關（e.g. 約 20-25%病患患有 filaggrin 基因突變、ceramide 濃度減少）
魚鱗癬和 filaggrin 的缺陷有關，常合併異位性皮膚炎！
- 診斷（4 取 3）
 1. Pruritus 很癢

2. 皮膚病灶符合典型形態與分布

嬰兒	臉、頭皮、軀幹、extensor side
小孩	眼周、口周、脖子、Flexor side
成人	後頸、手掌、flexor side

3. 慢性或反覆性發作

4. 個人或家族異位性病史

- 其他特徵：皮膚乾燥、黑眼圈、眼眶下摺紋(Dennie-Morgan)、耳朵下方龜裂、掌紋增加、毛囊角化、魚鱗癬(ichthyosis)、白色糠疹
- 皮膚感染風險高，易出現細菌(S. aureus)、病毒(Herpes)、黴菌感染
- Wiskott-Aldrich syndrome
 - o X-linked
 - o Triad: 血小板低下 (出血)、免疫功能低下 (反覆性化膿感染)、異位性皮膚炎
- 治療：**保濕**、不要抓；局部類固醇、外用 **calcineurin inhibitor** 藥膏(Tacrolimus, Pimecrolimus)；照光治療 (Narrowband UVB (NB-UVB))、免疫調節藥物、生物製劑(Dupilumab [Anti-IL4/IL-13])

接觸性皮膚炎 Contact dermatitis

- 刺激性皮膚炎 (Irritant contact dermatitis, ICD)：接觸到具刺激性的物質 (酸/鹼/有機溶劑)
 - o 病灶僅限於暴露位置且界線分明
 - o 一般情況是急性，但也可以為慢性
- 過敏性皮膚炎 (Allergic contact dermatitis, ACD)：**Type IV (delayed) hypersensitivity**
 - o 對小分子過敏原過敏，可能來自金屬、抗生素、染劑 (對苯二胺, PPD)、化妝品、植物等
 - o 可安排 patch test 確認過敏原

脂漏性皮膚炎 Seborrheic dermatitis

- 發紅脫屑的皮膚炎，分布於皮脂腺活躍處：臉的 T 字部位、**鼻翼**、耳後、頭皮
- 可能和 **M. furfur** 有關→HIV 患者的病灶會很嚴重
- 皮膚橘紅、癢、帶有**白色脫屑**，在冬天乾冷時較惡化
- **帕金森氏症**的患者常出現脂漏性皮膚炎的表現，機轉仍不清楚
- Cradle cap：新生兒的脂漏性皮膚炎，分布於頭皮→紅斑/脫屑/結痂
- 治療：Ketoconazole 洗髮精、煤焦油、外用類固醇等

蕁麻疹 urticaria

- 蕁麻疹(urticaria)：暫時性的一塊塊皮疹(**膨疹 wheal**)，非常癢，為 papillary body 的水腫
- 血管水腫(Angioedema)：真皮/皮下組織水腫，邊界不清，以『腫』為主要表現
- 為 **IgE-mediated**，即 **type I Hypersensitivity**，IgE 和過敏原結合、引發肥大細胞、組織胺
- 病因：免疫、食物、藥物、感染、補體、物理因素(壓力/光/冷/皮膚劃紋)誘發
- 急性蕁麻疹 (<6 週)
 - o 急性發作、數小時內消失 (>24 小時要小心血管炎)
 - o 避免碰觸過敏原，給**抗組織胺**；若有 anaphylaxis shock，給 IM **epinephrine**
- 慢性蕁麻疹 (>6 週)：大部分找不到原因
 - o 治療：**第二代抗組織胺**為主、口服類固醇 (短期)、Omalizumab (anti-IgE)、免疫調節藥物等

扁平苔癬 Lichen planus

- 典型皮膚病灶為紫紅色、扁平、發癢的多角形平頂丘疹(flat-topped papule)，常出現在手腕、腳踝、下背→5P: Planar, Polygonal (多角形), Pruritic, Purple, Papule
- 病灶表面和口腔黏膜可能有白色蕾絲線條(Wickham's striae)
- 口腔內的潰瘍型扁平苔癬，要小心轉成鱗狀上皮癌的可能性(1-3%)
- 大部分自行緩解，只需止癢/類固醇藥膏



其他

- 鬱血性皮膚炎 (stasis)
 - o 導因於下肢的深層靜脈瓣膜功能不足，造成血液鬱積
 - o 表現為濕疹樣的皮膚炎，伴隨發炎性的丘疹、脫屑、糜爛與結痂
- 缺脂性皮膚炎 (Asteatotic dermatitis)
 - o 又稱乾燥性皮膚炎、冬季惡化 (冬季癢)，老人常見，小腿脛前和手臂外側最明顯
 - o 處置：保濕為主，抹凡士林，洗澡次數不宜多，不要泡溫泉
- 牛皮癬 (Lichen simplex chronicus)：慢性搔抓，導致局部的苔癬化、皮膚上有紅帶紫的脫屑斑塊
- 汗皰疹(pompholyx)：水泡型皮膚炎，主要分布於手/腳掌患者，可能有多汗，濕熱環境較常發生

三、乾癬與糠疹

乾癬 Psoriasis

- 為一慢性反覆發作之皮膚病，發病期分別為 23 歲和 55 歲兩個高峰期，越早發作症狀越嚴重
- 免疫性疾病，上皮過度活化，產生大量的脫屑性病灶，基因型：HLA-Cw6
- 好發身體 extensor side、頭皮
- 分類：
 - o 尋常性(Psoriasis vulgaris)：最常見，有些會融合成大塊的地圖 (geographic)
 - o 90%尋常性乾癬病人有指甲病灶(psoriatic nail disease)：
 - 點狀凹陷(Nail pitting)最常見、甲床點滴樣 (oil spots=Salmon patch) 具高度特異性、甲床分離(onycholysis)、指甲增厚(subungual hyperkeratosis)
 - o 雨滴狀(Guttate psoriasis)：為許多橘紅色(salmon pink)的點滴狀病灶，多見於年輕人和鏈球菌感染後有關
 - o 乾癬性紅皮症(Psoriatic erythroderma)
 - o 全身膿泡型(Generalized pustular psoriasis, von Zumbusch)：為急性乾癬，發病時多有發燒和突發性全身性無菌性膿泡，會融合成 circinate lesion= "lake" of pus
- 誘發因子(TIDES)：Trauma、Infection(鏈球菌)、Drugs(β-blocker、鋰鹽)、壓力、Sunlight
- 會加劇乾癬的藥物→口訣：ABCD+GI
 - o A: ACEi, anti-malaria
 - o B: β-blocker
 - o C: Corticosteroid (Topical)



- D: Depression: Lithium
- G: Gemfibrozil (Fibrates)
- I: Imiquimod, INF- α
- **Koebner phenomenon**：從皮膚的抓傷處出現新的皮膚病灶，常為線狀
- **Auspitz sign**：將 scale 移除後，可見下方有出血點
- 10-25%乾癬病人會造成關節疾患，也就是乾癬性關節炎(ReA)
- 治療：外用（類固醇/煤焦油(tar)/Vit D）；照光（narrow-band[311 nm] UVB、PUVA）；口服藥（A 酸、cyclosporine、MTX），生物製劑(TNF- α /IL-12,23/IL-17/IL-23)
- **禁用口服類固醇**→停藥後會反彈、更嚴重

玫瑰糠疹 Pityriasis rosea

- 可能和 **HHV-6、HHV-7** 有關
- 先有前驅病灶(herald patch)：橘紅色的橢圓斑塊，周邊一圈脫屑
- 前驅病灶後 1-2 周→全身發疹→背部呈對稱的聖誕樹分布→6-8 周消退

白色糠疹 Pityriasis alba

- 小塊的脫色素斑，界線不明顯，主要出現在小孩和青少年，為自限性疾病
- 病因不清楚，病灶在日照後比較明顯（ex. 夏天），可能和周圍的皮膚變深色有關係
- 鑑別診斷：汗斑(by. 黴菌感染)→可用 KOH 鑑別

四、水疱病

水疱性表皮鬆懈症 Epidermolysis bullosa

先天性：Heredity epidermolysis bullosa (泡泡龍)

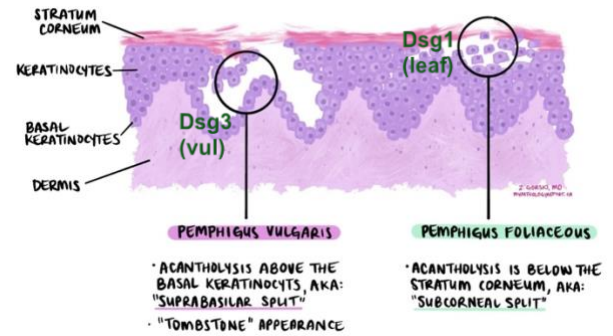
- 俗稱泡泡龍，為一種罕見的遺傳性疾病，發生率 20/1,000,000
- **基因異常**導致皮膚內的**蛋白異常**引起水泡，**和自體免疫無關**
- 依照皮膚裂解的位置、由淺至深分成三種類型
 1. Epidermolysis bullosa simplex (EBS)：裂解在表皮基底層(St. basale)的角質細胞，大多和 keratin 5、keratin 14 異常有關→最常見
 2. Junctional epidermolysis bullosa (JEB)：裂解在表皮基底層與真皮層之間(St. lamina)，大多跟 laminin 有關
 3. Dystrophic epidermolysis bullosa (DEB)：裂解在 superficial papillary dermis，大多跟 collagen VII 異常有關
- 臨床症狀：輕微受傷就會因表皮裂解而出現水泡，病灶可能為局部或全身，也可能伴隨指甲、牙齒、眼睛、頭髮的異常
- 沒有特別的治療方式，支持性治療為主

天皰瘡 Pemphigus

後天性：天皰瘡、類天皰瘡、linear IgA、dermatitis herpetiform

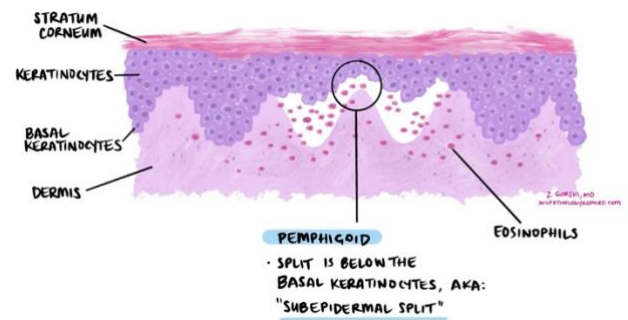
- 流病：好發 **40-60 歲 (較年輕)**，猶太、中東、地中海一帶；預後較差
- 症狀：抗體攻擊 **desmosome**，導致皮膚與黏膜出現易破裂的水泡(flaccid blister)、**Nikolsky's sign(+)**

- 診斷
 1. 切片: **Suprabasal** cleft in epidermis (不會侵犯到 dermis)
 2. DIF: Epidermal intercellular IgG auto Ab (蕾絲狀)
 3. 抗原: Dsg1 (淺)、Dsg3 (深)
- 尋常性天疱瘡 (pemphigus vulgaris)→攻擊 Desmoglein 3 (較深) , 在 **suprabasal** 裂解
常造成**黏膜**潰瘍, 進食疼痛; 皮膚水疱易破, 只看到 erosion
- 落葉型天疱瘡 (pemphigus foliaceus)→攻擊 Desmoglein 1 (較淺) , 在 **suncorneal** 裂解
黏膜影響較少, 主要在**皮脂分泌多**的區域分布
- 治療: 全身性類固醇 (一線) ; 免疫抑制劑; 血漿置換; Rituximab



類天皰瘡 Pemphigoid

- 流病: 好發 70-80 歲 (較老) , 為西方國家最常見的水泡病; 預後較好
- 症狀: 比較不會侵犯黏膜, 分布在**皮膚摩擦皺褶處**, 因此比較深層, 所以有大而緊實壓不破的水泡, Nikolsky's sign(-)
- 診斷
 1. 切片: **Subepidermal blister** (水泡隣隣的, 因為會活化補體系統, 導致 eosinophil、neutrophil 等發炎細胞聚集)
 2. DIF: **Basement membrane linear C3 和 IgG 沉積**
 3. 抗原: BP230 (BPAG1)、BP180 (collagen XVII) (在 lamina lucida, 較深)
- 治療: 取決於範圍與嚴重程度, 和天皰瘡差不多用類固醇、免疫抑制劑, 但劑量較低



五、色素性皮膚疾患

脫色素病灶: 白斑/白化症

- 白化症 (Albinism): melanocyte 數量正常, 但缺乏 tyrosinase, 導致 **melanin 減少**
 - o 皮膚白、粉紅, 對於陽光敏感、**皮膚癌風險↑** (防曬很重要)
 - o 頭髮會變白變黃、眼睛變淡藍甚至粉紅、視力常變差
- 白斑 (Vitiligo): 後天性色素脫失性皮膚病, 導因於**局部的 melanin 消失**
 - o 治療: ¹外用類固醇/²narrow band UVB/ 準分子雷射/ PUVA/ 色素移植

全身性色素沉著病灶

- 可能導因於系統性疾病 (ex. Addison's disease、肝硬化、血鐵質沉著症)、藥物(ex. amiodarone)、飲食 (胡蘿蔔素) 等
- **Addison's disease:** 導因於 ACTH 和 MSH 的分泌增加→刺激黑色素細胞

局部色素沉著病灶

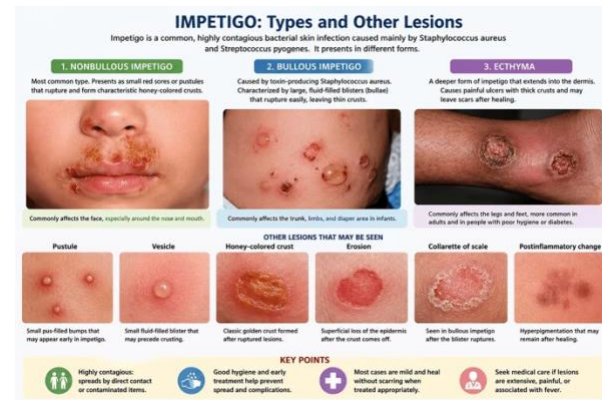
- 黑色素增生疾病
 - o 痣 (melanocytic nevi): 為 nevus cell 的良性增生, 要和 melanoma 區分
 - o 蒙古斑 (Mongolian spot): 好發腰薦部的灰藍色斑, 亞洲常見, 長大會自行消退
 - o 太田母斑 (Ota): 主要影響**單側**三叉神經的第一和第二支 (眼眶周圍、臉頰、結膜、硬顎), 常見於亞洲女性
 - o 伊藤氏母斑 (Ito): 罕見, 常見在**肩和側胸**有大片均勻藍灰色斑
 - o 峴氏母斑 (Hori's nevus): 後天性, 多發生於成人**雙側**臉頰, 灰藍色或是咖啡色的斑塊, 又稱遲發性兩側太田母斑

- 咖啡牛奶斑 (Café au lait spot)：神經纖維瘤(NF)
- 肝斑 (melasma)：臉部對稱的局部色素沉著，和賀爾蒙變化有關，懷孕及停經前服用避孕藥都可能造成，稱為" mask of pregnancy" (和肝病無關)；標準治療為 **4% Hydroquinone**，雷射治療效果差，小心反黑
- 雀斑 (freckle)：小而深的 macule，主要在小孩出現，出現在陽光曝曬處
- 斑痣(nevus spilus)：咖啡色的 Patch 上，合併有深咖啡色的 Macules
- Erythema ab igne：局部網狀紅斑和色素沉著，和慢性的熱/紅外線暴露有關，未來出現鱗狀上皮癌風險增加

六、感染性皮膚疾病

細菌性 Bacterial

- 葡萄球菌性燙傷樣皮膚綜合症 (Staphylococcal scaled skin syndrome, SSSS)
 - o 廣泛脫皮病灶，和 **S. aureus** 分泌的**外毒素 Exfoliatin A&B** 相關 (攻擊 **desmoglein-1**→上皮裂解)
 - o 局部潮紅→全身皮膚發紅→小水泡融合成大水泡→24-48 小時開始脫皮
 - o **Nikolsky sign (+)**，不會侵犯黏膜，也不會留疤！(like pemphigus foliaceus)
 - o 治療：Oxacillin、supportive care
 - 中毒休克症候群 (Toxic shock syndrome, TSS)
 - o **S. aureus** 分泌之 **Toxic shock syndrome toxin 1 (TSST-1)**，以及 **S. enterotoxin** 和 **GAS** 分泌之 **streptococcus pyrogenic exotoxins (SPE)**，也就是超級抗原所導致之系統性症候群
 - o 超級抗原會直接和 **MHC II** 結合，激活 **T cell**，造成 **IL-1, IL-6, TNF-α** 等釋放
 - o 造成患者出現發燒、低血壓、紅疹、多重器官衰竭
 - Impetigo (膿痂疹) & Ecthyma
 - o 致病原：**S. aureus** 最常見，有時為 **Group A Streptococcus (S. pyogenes)**
 - o 在表皮的感染叫 impetigo，外觀為一粒粒小紅色瘡，沒治療會跑到 **dermis** 變 ecthyma
 - o 傳染性膿痂疹 (Impetigo contagiosa/ Non-Bullous)：Group A Streptococcus (S. pyogenes)為主 (已開發國家以 S. aureus 最常見)，**產生易破的小水泡**，黃色滲液、結痂
 - o 膿疱性膿痂疹 (Bullous Impetigo)：由 **S. aureus** 分泌的**外毒素 Exfoliatin A** 引起
- <cf.>SSSS 的致病菌也是 S. aureus 分泌的外毒素，但是是 Exfoliatin B
- 紅癬 (Erythrasma)
 - o 病原體：微細棒狀桿菌(Corynebacterium minutissimum)
 - o 多見於**成年男性**，好發腋下、腹股溝、大腿與陰囊接觸的股內側、臀縫、女性乳房下，出現**邊界明顯的紅色 patch**，之後會變褐色
 - o **Wood's lamp**：C. minutissimum 分泌的 coproporphyrin III 在伍氏燈下會呈**珊瑚紅**螢光
 - 丹毒 (Erysipelas)：β-hemolytic strep. (e.g. Group A Streptococcus)為主，淺層且界線分明、會壓痛的皮膚紅腫
 - 癩瘋病(Leprosy=Hansen's disease)：病原體為 M. leprae，侵犯皮膚和神經
 - o Tuberculoid→少量的脫色素斑塊、斑塊感覺變差、無汗
 - o Lepromatous→對病原的免疫力差，無法產生足夠的細胞免疫出現大量皮膚病灶；晚期出現獅子臉、馬鞍鼻



病毒性 Viral

- 玫瑰糠疹 (Pityriasis rosea)
 - o 可能和 **HHV-6**、**HHV-7** 有關

- 先有前驅病灶(herald patch)：橘紅的橢圓斑塊，周邊一圈脫屑
- 前驅病灶後 1-2 周→全身發疹→背部呈對稱的**聖誕樹**分布→6-8 周完全消退
- 第一次 VZV：水痘(chicken pox)=HHV-3
 - 傳染期：出疹前 2 天~出疹後 5 天
 - 臉部 papule→ 軀幹四肢水泡(vesicle)，看起來像玫瑰花瓣上的露珠(dewdrops on a rose petal)→8-12 小時內變膿胞(pustule)和痂(crusts)
 - 成人症狀較明顯且嚴重，孕婦在第一產程感染會造成 fetal varicella syndrome
 - Tzanck smear：giant and multinucleated acantholytic epidermal cells
 - 治療：出疹 24 小時內給 Acyclovir；禁止給予 Aspirin 退燒→Reye's syndrome
- VZV 復發：帶狀疱疹(Herpes zoster)
 - 水痘病毒潛伏在感覺神經節
 - 疱疹後神經痛 (Postherpetic neuralgia, PHN)：容易發生於三叉神經第一分支(V1)
 - **Ramsay-Hunt syndrome**：病毒侵犯膝狀神經節(geniculate ganglion)則會有外耳道疱疹、味覺異常、耳鳴、**顏面神經麻痺(Bell's palsy)**
 - 治療：出疹 72 小時內給 **Acyclovir**
- 單純性疱疹 HSV
 - 以叢聚的疼痛水泡表現，反覆發生
 - 病原分成 HSV-1 (主要在嘴唇、手) 和 HSV-2 (主要在生殖器)
 - Tzanck smear 看到 multinucleated giant cell
 - 異位性皮膚炎患者，可能產生廣泛 HSV 病灶→Eczema herpeticum
- 多型性紅斑(Erythema multiforme)
 - 致病原：通常是 **HSV 或藥物**引起
 - 典型皮疹為「**靶心樣 (target lesions)**」紅斑，**對稱**分布在**四肢遠端**
 - 可分為輕型(EM minor)與重型(EM major)，後者會影響口腔等黏膜
 - 治療以支持性療法為主，重複發作可考慮**抗病毒藥物(Valaciclovir)**預防
- 傳染性軟疣(molluscum contagiosum)
 - 為痘病毒(Poxvirus)的傳染性軟疣病毒(molluscum contagiosum virus, MCV)感染，不是 HPV！
 - 產生臍狀(umbilicated)病灶，小孩常見，大部分會自行緩解若為性傳染、或患者擔心，可考慮冷凍/刮除等治療
- 病毒疣 (Verruca, wart)
 - **HPV** 感染，造成過度角化丘疹；**上常有黑點 (栓塞微血管)**
 - 容易傳染，亦可能越長越多，治療以冷凍或外用水楊酸/A 酸藥膏為主
 - 尋常疣 (Verruca vulgaris)：常長在手指、指甲
 - 足底疣 (Verruca plantaris)：會因疼痛影響行走，**刮去後表皮可見小黑點 (和雞眼鑑別)**
 - 扁平疣 (Verruca Plana)：常見於青少年，又叫 juvenile wart，常見於顏面、頸部、手背或前胸的皮膚色多發性丘疹
- 去看兒科：傳染性紅斑 (erythema infectiosum)、Roseola infantum、麻疹(Measles)、腸病毒

真菌性 Fungus

- 汗斑 (Pityriasis versicolor)=變色糠疹
 - 病原體：**Malassezia furfur**，造成皮膚出現小的色素變化斑塊
 - 位置主要在軀幹/肩膀，喜歡長在皮脂腺豐富的地方，所以也可侵犯毛囊、皮脂腺
 - KOH 能看到典型『**spaghetti and meatball**』
 - **Wood's lamp**：淡黃色或銅橘色(coppery-orange)

- 治療：保持乾燥、避免流汗；塗抹 Ketoconazole、Econazole、Terbinafine；範圍大可口服 Itraconazole、Fluconazole
- 念珠菌感染(candida)
 - 由伺機性感染白色念珠菌(Candida albicans)所致，為酵母菌(Yeast)
 - 主要發生在對摩處，重點是皮膚病灶周圍有衛星樣病灶(satellite)
 - KOH 能看到出芽孢子(yeast form)、pseudohyphae
- 皮癬菌 (Dermatophyte)：包括頭癬、體癬、股癬、香港腳、灰指甲
 - **環形病灶，邊界脫屑**，但中間正常(central sparing)，KOH 能看到菌絲 (看到任何脫屑病灶，都要考慮到皮癬菌感染的可能性!!!!)
 - 頭癬(Tinea capitis)：most commonly Trichophyton @髮內(無螢光) or Microsporum (M. canis、M. audouinii) @髮外，大致 Wood's lamp 會呈綠色螢光，∴頭癬感染深及毛囊→ 必 PO 抗黴菌藥物 115-1
 - 治療：外用抗黴菌藥膏為主 e.g. Imidazole 類；反應不好考慮口服用藥，包括 Terbinafine (首選，但須注意肝功能)、Itraconazole、Griseofulvin (只有抑菌效果，主要用於頭癬和灰指甲)

寄生蟲：疥瘡(Scabies)

- 機轉：身體對疥蟲及其產物 (卵、糞便) 產生 **Type IV (=Delayed type) hypersensitivity**
- 症狀
 - 典型症狀為皮膚癢，由於疥蟲是夜貓子，所以夜間會更嚴重
 - 人類對疥蟲及其排泄物產生過敏反應，故皮膚會出現紅斑、丘疹、Burrow (膚色的山脊)、scabietic nodule、crusting psoriasiform (厚厚的痂皮)
- 病程：**初次感染後有 4-6 週的潛伏期**；再次感染則大約 1-3 天症狀就會出現
- 病灶分布：疥蟲喜歡人體皮膚皺褶處及較柔軟的地方，如手指間、手肘、腋窩、肚臍、會陰、屁股、大腿，成人較少長在脖子上；嬰兒會長在臉上、手腳掌
- KOH：可見疥蟲、蟲卵、排泄物，看到其中一樣即可確診
- 挪威型疥瘡(Norwegian scabies)
 - 又稱 **crusted scabies, Hyperkeratotic scabies**，大多發生在免疫不全或有神經學疾患的病人
 - 一般疥瘡病人通常身上最多只會 12 隻活疥蟲，但挪威型疥瘡病人可以有 200 萬隻，救命
 - 病灶呈明顯的過度角化(hyperkeratosis)以及結痂(crusted)，但不一定會很癢
 - 治療：Permethrin 5% + 口服 Ivermectin (小孩、孕婦禁用)
- 預防：避免觸碰患者皮膚、衣物、床單；患者接觸過的東西要用 **>60°C 的熱水消毒**，亦可用塑膠袋封好，擱置兩個禮拜 (疥蟲離開人體約 2-3 天會死亡，但卵要 2 週才會孵化)
- 治療：必須從脖子塗抹到腳底，全身都要塗到

性傳染病 STD

- HSV：生殖器潰瘍常見成因 (疼痛/反覆發生)，常導因於 **HSV-2**
- **HPV 6 & 11** 和菜花有關；16 和 18 則和癌症有關
- 梅毒(syphilis)：為梅毒螺旋體(T. pallidum)的感染，經性行為/母子垂直感染
 - 一期：**無痛硬性**下疳(chancere)
 - <比較> **軟性**下疳(Chancroid)：由 Haemophilus ducreyi 造成，會痛
 - 二期：手腳掌出現**界限明確、紅銅色的圓形斑(Copper-penny lesion)**、全身性症狀 (頭痛、倦怠、發燒...)、梅毒性落髮 (syphilitic alopecia)→像被蟲咬(moth-eaten)，此時具**高度傳染性**，約 2-6 週後症狀自動消失
 - 隱性期(latent phase)：無症狀，傳染力下降
 - 三期：約感染後 3-7 年，主要病變為**梅毒腫(Gumma)**，未接受治療則有 10%會變成**主動脈炎/動脈瘤**等心血管疾病，再過 10-20 年發生**神經性梅毒**

- 診斷：VDRL/RPR (篩檢/追蹤治療效果) 、TPHA (確診用/治療後持續(+))
- 治療：Penicillin G Benzathine (一線) ；過敏可給 Tetracycline/Doxycycline
- 反覆生殖器/口腔潰瘍，視力變差→小心 Behcet disease
 - 此病 Pathergy test(+)→皮膚被針刺後，48 小時內出現發炎性膿疱
 - 又稱絲路病 (土耳其盛行率高) 、和 HLA-B51 有關

七、皮膚附屬器疾患

皮脂腺 / 汗腺

- 痤瘡(Acne vulgaris)：俗稱青春痘，為**毛囊皮脂腺**的發炎
 - 和角質栓子(comedone 粉刺)、雄性素、丙酸痤瘡桿菌(P. acnes)有關
 - 治療包括外用 benzoyl peroxide/A 酸；口服抗生素；口服 A 酸
 - 註：口服 A 酸：會造成皮膚/嘴唇乾、血脂和肝功能升高、致畸胎性
- 化膿性汗腺炎(Hidradenitis Suppurativa) **115-1**
 - 不是汗腺「感染」，而是**毛囊阻塞、角化異常**，造成阻塞與慢性發炎反應
 - 好發**女性**，主要影響部位為**腋下**，其次為鼠蹊部、大腿內側
 - Rf: 肥胖、抽菸
 - 最常見的初始表現是發炎性結節及化膿，但由於這個疾病極易慢性化，**長期會形成反覆發生的皮膚隧道(skin channel)、開放性痤瘡(open comedones)及結痂**
 - 治療：調整生活方式、使用抗生素、清創引流，在非常嚴重時才考慮切除、anti-TNF- α (adalimumab)
- Furuncle (癰) & Carbuncle (癰)
 - Furuncle 是**單一顆急性毛囊炎**合併毛囊周圍真皮和皮下組織發炎以及化膿，
 - Carbuncle 是**多顆毛囊炎**合併成的一大塊發炎化膿組織
- 酒糟(rosacea)：無粉刺可和痤瘡鑑別
 - 臉部的慢性發炎→持續紅斑、微血管擴張、潮紅，有時出現丘疹和膿疱
 - 白種人較多，慢性可能造成 rhinophyma (酒糟鼻)
 - 治療包括 metronidazole 藥膏 (不是類固醇！) ；急性發作可給口服抗生素
- 口周皮炎 (Periorificial dermatitis)
 - 好發年輕女性，類似酒糟，主要在口周和眼周
 - 治療為 metronidazole 藥膏或口服抗生素！**給類固醇可能惡化**

頭髮

- 頭髮生長分成 Anagen (生長期) 、Catagen (停止生長) 、Telogen (休止期)
- 不正常的落髮量：一天掉>100 根頭髮
- 雄性禿(Androgenetic alopecia)
 - 最常見→前額髮線後退 (M 型) +頭頂侵犯、毛髮變細
 - 和 DHT 有關，由睪固酮經毛囊的 5 α -reductase (type II)產生
 - 治療包括 Minoxidil (落健主成分) 、5 α -reductase inhibitor (ex. Finasteride)、植髮
- 圓禿(Alopecia areata)，俗稱鬼剃頭
 - 可能和**免疫攻擊毛囊**有關，造成一至多塊的圓形落髮區域
 - 有時全身的毛髮都脫落(active hair loss)，指甲也可能受影響，產生凹陷、粗糙等表現
 - 治療包括局部類固醇、免疫調節藥物等；若只有局部落髮，通常之後會自己長出來，不一定要治療
- 生長期落髮：分裂的毛囊受到化療/放療影響→大範圍落髮

- 休止期落髮：提早進入休止期，和系統性因素、營養、藥物等有關
- 其他：外力、感染性 ex.梅毒→如蟲亂咬 Moth-eaten hair loss

八、良性皮膚疾患

嬰兒血管瘤(hemangioma)

- 嬰兒最常見的血管腫瘤，良性，自限性（大部分在五歲前自行消退）
- 分 proliferation 期（內皮快速增殖）和 involution 期（出生後一年開始消退）
- 治療：若影響重要部位要治療，可注射高劑量類固醇、INF- α 、Propranolol；染料雷射(dye laser)；外科切除

葡萄酒色斑(Port-wine stain)= 微血管畸形(capillary malformation)

- 為微血管畸形造成的紅斑，會隨成長變大、顏色變深、終生存在
- 可能會合併一些症候群
 - o **Sturge-Weber syndrome**：色斑長在 CNV1、青光眼、癲癇、智力障礙、choroid plexus 鈣化
 - o **Klippel-Trenaunay syndrome**：四肢有 capillary-lymphatic-venous for malformation
- 治療：化妝或染料雷射(dye laser)

脂漏性角化症 (Seborrheic keratosis, SK)= 老人斑

- 說是老人斑但其實 30 歲就會有，由不成熟的角質細胞增生而成，表面看起來油油的，顏色呈棕/黑，像是『貼在皮膚上(stuck-on)』
- **Leser-Trelat sign**：突發大量的老人斑，記得要查腸胃道癌症(paraneoplastic syndrome)
- 一般不需特別治療，可用電燒、冷凍、雷射

化膿性肉芽腫 (Pyogenic granuloma)

- 為發生外傷或手術後迅速增生的血管腫瘤，既沒有膿也沒有肉芽腫，只是舊稱
- 相對常見，女性較多，特別是懷孕時發生於鼻中膈，常有流鼻血症狀，稱 pregnancy tumor
- 亮紅色的良性腫塊，輕微觸碰容易出血，可用外科切除、冷凍手術或電燒處理

其他

- 表皮樣囊腫(epidermal cyst)：俗稱粉瘤
 - o 真皮層出現由上皮細胞組成的囊袋，表面常會有開口，囊腫若破掉會引起發炎
- 汗管瘤(syringoma)
 - o 良性的汗管腺瘤，女性常見，主要分布於眼周
 - o 處置：切除、冷凍、電燒、CO2 雷射
- 疤痕
 - o 包含肥大性疤痕（局限於傷口的疤痕增生）、蟹足腫（超過原傷口範圍）和體質有關，常發生胸骨處等皮膚張力大處，病灶可能會癢
 - o 治療包括注射類固醇、液態氮、雷射、矽膠貼片、切除+放療
- 黑色棘皮症(Acanthosis nigrican)
 - o 皮膚絨毛狀增生，顏色變深（看起來髒髒的）
 - o 分布於頸、腋下等皺褶處
 - o 可能和胰島素抵抗有關，部分和腫瘤有關（尤其是腸胃道/生殖泌尿道），部分則和藥物有關（高劑量菸鹼酸、類固醇、口服避孕藥、生長激素）

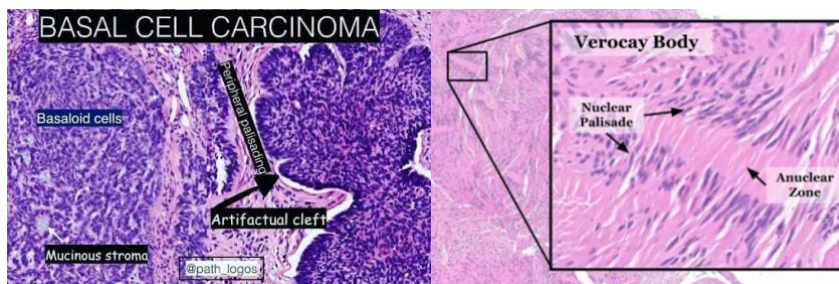
九、癌前病灶與皮膚癌症

癌前病灶

- 日光性角化症 (Actinic keratosis, AK)
 - o **慢性日曬傷害(UVB)**所產生，為**鱗狀細胞癌 SCC**的前期病變，惡性率達 20%
 - o 大多分布在臉部、頸部等易暴露在陽光下的部位，常見於農夫、工人或水手
 - o 病理特徵：parakeratosis, dyskeratosis, atypical keratinocytes
 - o 治療：刮除/電燒/冷凍治療/手術切除；局部塗抹藥物 5-FU (fluorouracil)、Imiquimod、TCA(trichloroacetic acid)；光照療法
- **SCC in situ**：癌化的細胞尚未超過基底膜，包括 **Bowen disease**（紅色的乾癬樣病灶）、**Erythroplakia of Queyrat**（生殖器的紅色斑塊）

基底細胞癌 BCC 最常見

- 由表皮細胞之**基底細胞**轉變而來，為人類最常見的皮膚癌
- 發病年齡多**>40 歲**，**男性**多，白人較常見
 - o 致病因子：多和**紫外線照射(UVB)**或 **PTCH gene mutation** 有關，**砷的接觸史**也和 BCC 有關
 - o 好發**頭頸部**，尤其是鼻子、下眼瞼、臉頰，皮膚表層可見無法移動、**無痛的硬塊**，表面發亮像珍珠，並於皮膚表淺可見**末梢血管擴張現象(telangiectasia)**
 - o 具有局部侵犯性，但轉移風險低，預後良好
- 型態
 1. Nodular：最常見
 2. Ulcerating：像是被老鼠咬過(rodent ulcer)
 3. Pigmented
 4. Sclerosing
 5. Superficial
- 病理關鍵字：不典型的類基底細胞、核大細胞少、**腫瘤周邊空白間隙(retraction artifact)**像孤島(tumor island)、**nuclear palisading 柵欄狀排列**
- 治療：**手術切除為首選**、針對危險區域用 Mohs micrographic surgery



鱗狀細胞癌 SCC 第二常見

- 源於**角質細胞(keratinocyte)**，常見於**老年男性**
- 好發於長期日曬部位，如臉、手臂、頭皮，亦可見於口腔、食道等黏膜處
- 危險因子：陽光、輻射、砷、瀝青、SPT、HPV-16, 18, 31
- 外觀常為增厚結節、潰瘍或結痂病灶，有時會出血或不易癒合
- 和 BCC 相比，**SCC 轉移風險較高**，特別是發生在口腔、生殖器或慢性傷口處時 **115-1**
- 治療：**首選為外科切除**，其他如 BCC
- **角化棘皮瘤(Keratoacanthoma)**：SCC 變型，圓頂狀結節，中央凹陷塞滿角質像火山口

黑色素瘤 Melanoma

- 由黑色素細胞(melanocyte)癌化生成，**時常經由淋巴轉移**，致死率極高
- ABCDE 法則：Asymmetry（不對稱）、Border（邊緣不規則）、Color（不均勻/超過一種顏色）、Diameter(>6 mm)、Enlargement（短時間內持續增大）

- 危險因子：過度日曬、皮膚型、家族史、黑色素母斑>100 個、淺膚 + 紅/金髮 + 藍/綠眼 + 易曬傷不易曬黑 (Fitzpatrick I/II) 。基因 MC1R 變異 → 嗜酪黑色素 (pheomelanin) 防護差。 **115-1**
- 生長期：分為水平生長期 (**局限上皮膚**，較不具侵犯性) 和垂直期 (**侵入真皮層**)
- **腫瘤的厚度 (侵犯深度) 影響轉移的可能，最重要的預後因子**
- Melanoma 亞型
 - o Superficial Spreading Melanoma (70%)：水平期長達兩年，較晚進入垂直期，白人最常見
 - o Nodular melanoma (15%)：第二常見，沒有水平期，直接進入垂直期，生長快速，外觀像**藍莓**
 - o Acral lentiginous melanoma (5-10%)：**台灣人最常見的類型**，好發東方人和非洲裔，病灶多位於手掌、腳掌或指甲甲床；常見於**>60 歲老人**，因生長緩慢多在後期才發現，預後差
 - o Lentigo maligna melanoma (5%)：導因於慢性日光傷害，主要在老人出現；生長速度相當緩慢，水平期可到 20 年
- 常見的轉移位置：**淋巴結**、肺臟、腦、肝臟、骨頭
- 治療：依據深度決定，淺層(<1mm)可能手術切除即可；更深層、或是有轉移，可能需要化療、**標靶(Vemurafenib)**、免疫治療



Paget's disease

- 乳房：乳頭/乳暈的慢性潰瘍表現，和乳癌有很大的關聯性
- 乳房外：泌尿生殖器的慢性濕疹樣病灶，和 GI/GU/GYN 的癌症有關
→ 濕疹樣病灶，擦了類固醇/antifungal/antibiotic 都沒效，要想到
- 病理：上皮出現 “ **惡性腺癌細胞** ” (Paget cells)→ 偏大偏白的細胞

其他腫瘤

- 皮膚 T 細胞淋巴瘤(cutaneous T cell lymphoma · CTCL)
 - o 以**皮膚為最初**表現的 T 細胞淋巴瘤(淋巴/其他器官在後期也會受到影響)
 - o Mycosis fungoides 為最常見的一種，以 CD4 為主，以斑/斑塊/腫塊表現
 - o Sezary syndrome 則為廣泛皮膚侵犯+循環中出現惡性細胞(Sezary cell)
- 卡波西肉瘤 (Kaposi sarcoma)
 - o 一種血管腫瘤，和 **HHV-8** 有關，常出現在免疫抑制患者(ex. AIDS/移植)
 - o 臨床表現：一開始像瘀斑的斑疹或丘疹(ecchymotic-like macule/ papule)，之後範圍慢慢擴大成丘斑、結節、腫瘤，顏色常呈現紫色、紅色或棕色
 - o 切片特徵：patch stage→ plaque stage→ nodular stage (**spindled endothelial cell** 浸潤真皮層並排成束狀，散布著不規則的裂隙狀血管腔 **slit-like vascular space**，裡頭有許多紅血球)
 - o 可能侵犯皮膚 (紫紅色無痛病灶)、內臟 (腸胃道/呼吸系統)

十、藥物疹

固定性藥物疹

- 服用相同藥物，都會在同個部位出現藥物疹
- 常見引起藥物疹的藥物：Tetracycline, NSAID, Sulfa drugs, Aspirin, Barbiturates

Steven Johnson syndrome (SJS) & Toxic epidermal necrosis(TEN)毒性表皮症候群

- 常見藥物：**Carbamazepine (HLA-B1502)**、**Allopurinol(HLA-B5801)**、Phenytoin、sulfa 類、消炎止痛藥(NSAID)
- 水泡或破皮面積佔全身比例：**SJS<10%**；**TEN>30%**
- 裂解位置：**SJS 在 st. corneum**；**TEN 在 st. germinativum**
- 黏膜常侵犯因表皮真皮裂解→ Nikolsky sign(+)
- 症狀：發燒、嘴巴/生殖泌尿道破皮→大面積標靶樣(target-like)皮膚疹→皮膚脫落剩真皮層

<比較>DRESS (Drug reaction with eosinophilia and systemic symptoms)

- 廣泛皮疹 + eosinophil 高、臉水腫、少黏膜侵犯、遲發性 (用藥 2-6 周後)
- 治療以停藥為主，嚴重者需使用全身性類固醇，恢復期可能長達數週至數月

結節性紅斑 Erythema nodosum (EN)

- 唯一種脂肪炎(panniculitis)，長在小腿前脛的紅色皮下結節 (會痛)，有點像紅豆冰
- 好發於 20-40 歲的年輕女性
- 急性症狀發生於呼吸道感染 2-3 週後，先有發燒、喉嚨痛等→關節炎→鮮紅色的疼痛/壓痛結節
- 誘發因子：鏈球菌感染、不明原因、TB、Sarcoidosis、IBD、Behcet
- 大部分為自限性

十一、自體免疫疾病

紅斑性狼瘡 SLE

- 皮膚狼瘡(lupus)：分成急性/亞急性/慢性
 - 急性：malar rash、紅色丘疹、光敏感、和 SLE 關聯最大
 - 亞急性：環形(annular)紅疹和鱗狀丘疹(papulosquamous)
 - 慢性：多樣，包括圓盤型(discoïd，最常見)、脂膜炎(panniculitis)、凍瘡型、肥厚型等；和 SLE 關聯性較急性皮膚狼瘡低
- 新生兒：和母體 anti-Ro(SSA)(>80%)/anti-La 有關，造成環形紅疹和 AV block

全身性硬化症 Systemic Scleroderma

- 早期有雷諾氏現象→晚期手指硬化、指尖潰瘍、皮膚硬化
- LcSSc：CREST (皮下鈣化、雷諾氏、食道異常、硬指、微血管擴張)
- 硬皮症(scleroderma)：局部皮膚硬化，不會有雷諾、不會侵犯內臟，和全身性硬化症無關，病灶呈 plaque, linear

皮肌炎 Dermatomyositis

- 發炎性肌肉病變：近端無力+肌肉酵素↑
- 典型皮膚病灶：會癢、Heliotrope sign (上眼瞼淡紫色變化≡紅色眼影)、Shawl sign (頸前 V 字皮疹)、Gottron papules (紫色平頂丘疹，分布於手指關節背面)
- 成人患者可能和癌症有關，東亞要特別注意 NPC 鼻咽癌



類肉瘤病 Sarcoidosis

- 為一種多系統的肉芽腫性發炎，以肺部為最常見的侵犯處
- 臨床表現：肺 (肺門淋巴結腫、肺纖維化)、眼 (葡萄膜炎)、淋巴結、皮膚
- 皮膚表現多樣，常見為紅棕/黃棕色丘疹，用玻片壓出現如 apple-jelly 的色澤；病灶可能出現在疤痕/刺青處；切片下可看到許多肉芽腫浸潤
- 患者可能出現結節性紅斑(EN)，若合併發燒/肺門腫稱為 Lofgren syndrome，為一種急性的 sarcoidosis，預後好

十二、遺傳性疾病

神經纖維瘤 Neurofibromatosis (AD)

Dz	NF-1 (von Recklinghausen disease)	NF-2
比例	較多(90%)	較少(10%)

診斷條件	1. 咖啡牛奶斑(Café au lait spot) : ≥ 6 個 (青春前期 $>5\text{ mm}$; 後 $>15\text{ mm}$) 2. 腋下、鼠蹊雀斑 3. Lisch nodule : 虹膜上的 hamatoma 4. 神經纖維瘤 ≥ 2 個 5. 骨頭病變 : 蝶骨、脛骨 6. 視神經膠質瘤(Optic Glioma) 以上有 兩項 即可確診	雙側的聽神經瘤(acoustic neuroma) 或 一等親或兄弟姊妹有 NF-2 且有 (1) 單側聽神經瘤 (2) 室管膜瘤、腦膜瘤、神經鞘瘤、青少年後囊下性白內障
其他	兒童性早熟 ; 成人增加罹患嗜鉻細胞瘤的風險 ; 智能障礙	視網膜 hematoma
遺傳性	50% AD	100% AD

結節性硬化症 Tuberous sclerosis **AD**

- 血管纖維瘤 : 圓頂狀丘疹 , 容易誤認為痘痘
- 特徵 : **脫色素斑塊(Ash-leaf)**、**鯊魚皮斑(Shagreen patch)**、指甲纖維瘤(periuungal fibroma)、**腦室旁鈣化**、多發性的錯構瘤、**癲癇**、智力缺損、腎臟雙側巨大 angiomyolipoma
- 治療 : mTOR inhibitor (Everolimus)



Darier disease **AD** 115-1 (in choice with Hailey-hailey dz)

- ATP2A2 (ER, SERCA2) ; 罕見 , 晚發性 (10-20 歲發病) , 以大量**紅棕色**的脫屑丘疹表現
- 症狀 : 癢、脫屑、指甲 : 變薄、遠端裂開、出現典型的 V shape
- 分布在**皮脂分泌多 = 脂漏區 (前胸、背、頭皮)** 的區域
- 治療 : 防曬、外用 A 酸、口服 A 酸

Hailey-hailey **AD** 115-1

- ATP2C1 (Golgi) ; 三代家族史
- 特徵 : 糜爛性紅斑、裂隙、水泡 (濕衛生紙樣)、指甲 : 縱向白紋、夏天會惡化
- 分布在**皮脂分泌多**的區域、對磨處 (腋下、胯下、頸)
- 病理 : 棘層鬆解 (Dilapidated brick wall)
- 治療 : Combine=topical corticosteroids (for inflammation) + antibiotics (e.g., clindamycin or mupirocin)

尋常性魚鱗癬 ichthyosis vulgaris **AD**

- 魚鱗癬是一群遺傳性的皮膚角化症 , 外觀上有許多的皮膚鱗屑堆積
- 尋常性魚鱗癬的機轉為皮膚 **filaggrin 減少** , 導致皮膚乾燥、過度角化、**脫屑常合併異位性皮膚炎、毛孔角化症(keratosis pilaris)** , 好發四肢**伸側**
- 小丑魚鱗癬 Harlequin ichthyosis
 - o 又稱 ichthyosis fetalis , 為最嚴重的一種魚鱗癬
 - o **新生兒**出生時全身覆蓋厚重的角質鱗片 , 形成深裂縫 , 使皮膚外觀像小丑面具
 - o 過去預後極差 , 但現今早期使用雷諾 A 酸(retinoids)與密切照護可改善存活率

皮膚科的 Sign

Signs	解釋	疾病舉例
Darier sign	– 搓揉或敲擊病灶後，會產生蕁麻疹樣的變化（紅腫、癢） – 變化範圍僅限於病灶本身	– Mastocytosis syndrome – 少數 cutaneous lymphoma 或 histiocytosis
Dermatographism	– 用力劃過沒有病灶的皮膚會產生蕁麻疹樣的變化 – 變化範圍即是用力畫過的位置	物理性/誘發性(inducible)蕁麻疹
Hutchinson sign	黑色素細胞延伸到指甲周邊的皮膚	Melanoma
	鼻尖上的水泡	Zoster ophthalmicus (侵犯 CN5-1)
Auspitz sign	把乾癬上的脫屑刮掉後，會產生點狀出血	Psoriasis
Nikolsky sign	輕輕摩擦外觀看起來正常的皮膚，表皮即出現鬆動、脫層、甚至產生水泡	– Pemphigus △ Pemphigoid= (-) – SSSS – TEN
Koebner sign	受傷的位置出現新的病灶	– Vitiligo 白斑 – Lichen planus – Psoriasis
Fitzpatrick (=Dimple) sign	側向擠壓病灶（像擠痘痘），病灶會凹掉(太硬?)	Dermatofibroma
Apple-jelly sign	用玻片壓病灶可見其如蘋果醬般的黃色	Sarcoidosis

伍氏燈 Wood's lamp

- 光源：紫外光(365 nm)
- 色素沉澱：表皮的病灶會變深；真皮病灶不受影響

疾病	病原體	Wood's lamp 顏色
Tinea capitis 頭癬	Fungus	藍綠色
Pityriasis versicolor 汗斑	Malassezia furfur	黃綠色或橘色
Erythrasma 紅癬	Corynebacterium minutissimum	珊瑚螢光粉紅色
Vitiligo 白斑	Cell death	白色
Porphyria cutanea tarda (PCT) 緩發性皮膚病變紫質症	Urine	紅色